Ospedale Civile di Valdirosa
U.O.C. Anatomia Patologica
Direttore: Dott. Lorenzo Pieralisi

Via dei Mandorli 9
60127 Ancona
Segreteria: 071 5964310

REFERTO DI ESAME ISTOLOGICO

Biopsie endoscopiche gastriche

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**Enrico Bellandi**	Nato il:	**21/09/1967**
Codice fiscale:	**BLLNRC67P21A271Z**	Sesso:	**M**

N. istologico:	IST/2025/004812	Data prelievo:	14/05/2025
Reparto inviante:	Servizio di Endoscopia Digestiva	Data referto:	22/05/2025
Medico richiedente:	Dott. Fabio Tonnini	Priorità:	Ordinaria

NOTIZIE CLINICHE

Epigastralgia e dispepsia da circa sei mesi. All'EGDS mucosa antrale iperemica a chiazze. Biopsie secondo protocollo Sydney. Ricerca di Helicobacter pylori.

MATERIALE INVIATO

A) Antro gastrico: 2 frammenti (blocchetto A1).
B) Incisura angolare: 1 frammento (blocchetto B1).
C) Corpo gastrico: 2 frammenti (blocchetto C1).

DESCRIZIONE MACROSCOPICA

Frammenti bioptici di colorito grigio-rosato, di diametro massimo compreso tra 2 e 4 mm, inclusi in toto. Sezioni seriate colorate con ematossilina-eosina e Giemsa.

DESCRIZIONE MICROSCOPICA

Mucosa di tipo antrale e oxintico con infiltrato linfoplasmacellulare della lamina propria e granulociti neutrofili a livello del colletto ghiandolare. Alla colorazione di Giemsa si osservano microrganismi spiraliformi adesi all'epitelio foveolare. Non metaplasia intestinale, non displasia.

Sede	Infiammazione	Attività	Atrofia	Metaplasia intestinale	H. pylori
Antro (A1)	moderata	lieve	assente	assente	presente ++
Incisura (B1)	moderata	lieve	assente	assente	presente +
Corpo (C1)	lieve	assente	assente	assente	presente +

DIAGNOSI

Gastrite cronica attiva Helicobacter pylori positiva a prevalente localizzazione antrale. Stadio OLGA 0, assenza di lesioni preneoplastiche.

Il Dirigente Medico Anatomo-Patologo
Dott.ssa Silvia Marcantoni

Ancona, 22/05/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.